

Capitolul I

MANAGEMENTUL SARCINII

Pentru perioada sarcinii moaşa are obligaţia de a stabili un contact strâns între gravidă, familie şi ea însăşi. Din acest punct de vedere rolul moaşei este unul extrem de important pentru că supravegherea atentă şi corectă a sarcinii va avea ca rezultat un copil sănătos.

Stabilirea relaţiei între moaşă şi familia care vrea să aducă pe lume un copil se va face la prima consultaţie prenatală.

Prima consultaţie trebuie să cuprindă obligatoriu:

1. anamneza familială: date despre boli în familie – TBC, sifilis, diabet zaharat, HTA, boli genetice, afecţiuni congenitale;
2. situaţia economico-socială a familiei – grad de şcolarizare, loc de muncă, obiceiuri alimentare, consum de alcool, tutun sau alte droguri.
3. anamneza obstetricală:
   - ➲ data primei menstruaţii;
   - ➲ regularitatea ciclurilor menstruale;
   - ➲ numărul de sarcini;
   - ➲ numărul de avorturi la cerere sau spontane;
   - ➲ date referitoare la copiii aflaţi în întreţinere: naşterea, greutatea la naştere, starea la naştere, starea actuală a copiilor.
4. anamneza sarcinii actuale: ultima menstruaţie, primele mişcări fetale.

Gravida ar trebui dispensarizată din primul trimestru de sarcină (8-12 săptămâni de gestaţie). De fapt rolul unei moaşe într-o comunitate este de a identifica femeia gravidă, pentru că încă mai există femei care nu se prezintă la medic pentru supravegherea sarcinii.

Un studiu efectuat pe un eşantion de 600 gravide care au născut în Maternitatea "Cuza-Vodă" din Iaşi a demonstrat ca 30% din acestea nu aveau nici o consultaţie prenatală, 40% aveau 1-2 consultaţii şi 20% au avut sarcina urmărită corect atât de medicul de familie cât şi de cel obstetrician şi moaşă. Acest studiu demonstrează încă o dată rolul primordial al unei moaşe dintr-o comunitate în depistarea şi supravegherea sarcinii.

5. examen clinic sumar: greutate, talie, starea de nutriție a gravidei, examenul sânilor, examen genital. Se va nota mărimea uterului, aspectul colului. Acest examen va fi completat ulterior de medicul de familie.
6. sfaturi date mamei şi familiei:
   - ☑ evoluția sarcinii şi necesitatea controalelor prenatale pentru identificarea riscului obstetrical;
   - ☑ se va explica gravidei necesitatea efectuării unor investigații obligatorii pe parcursul sarcinii: grup sanguin, Rh, hemoleucogramă, glicemie, RBW (serologia sifilisului), examen de urină, culturi vaginale;
   - ☑ efectuarea unor ecografii – cel puțin 3-4 ecografii pe parcursul sarcinii:
     - ⇨ prima, la 12 săptămâni de gestație, care furnizează date generale despre făt,
     - ⇨ a 2-a, la 20-22 săptămâni de gestație, pentru a aprecia morfologia fetală şi a depista unele malformații de cord, sistem nervos, digestiv, renal,
     - ⇨ a 3-a, la 32-34 săptămâni de gestație, pentru a aprecia dezvoltarea fătului şi placentei,
     - ⇨ a 4-a în ultimul trimestru de sarcină.

   Toate aceste investigații sunt obligatorii pentru o sarcină normală.

Identificarea unor factori de risc impun alte examinări, cum ar fi: triplu test, amniocenteza pentru cariotip, examen pentru depistarea unor infecții intrauterine (ex: toxoplasmoza).

Riscul este cuantificat în grade de la 1 la 3: 1 = risc minor, 2 = risc moderat, 3 = risc sever.

7. promovarea alimentației naturale;
8. pregătirea pentru naştere. Se va insista pentru identificarea de către gravidă a următoarelor aspecte:

- →| declanşarea naşterii prin apariția contracțiilor dureroase, eliminarea dopului gelatinos, ruptura membranelor;
- →| naşterea propriu-zisă: perioada de travaliu cu durată aproximativă de 6 ore şi durata expulziei de aproximativ 20 minute.

La toate aceste discuții dintre moaşă şi gravidă ar trebui să participe şi soțul sau alți membri ai familiei. Discuțiile trebuie purtate cu mult profesionalism, indicațiile date gravidei se vor face prin cuvinte simple pentru a fi înțelese indiferent de gradul de instruire a gravidei.

Cel mai important lucru pentru moaşă este să câştige încrederea gravidei şi în final să fie acceptată ca un membru important al familiei.

9. sfaturi alimentare pe perioada sarcinii: în timpul sarcinii gravida va avea un regim echilibrat în proteine, glucide şi lipide, se va suplimenta consumul de vitamine şi minerale şi se reduce consumul de sare.

Alimentația gravidei pe perioada sarcinii va fi adaptată astfel încât greutatea adăugată pe parcursul sarcinii să nu depăşească 10 kg.

Tabelul 1. *Factorii de risc în sarcină*

FACTORI DE RISC ÎN SARCINĂ *(după May, Mahlmeister, adaptat)*	**Risc**
1. Factori socio-economici	
Vârsta maternă < 18 ani sau > 40 ani	2
Status marital: mamă singură, divorțată	2
Status socio-economic scăzut: fără ocupație/ocupație ocazională	2
Etnii: rromi, minorități naționale	2
Grad de educație – 10 clase	1
Dezordini ereditare sau genetice	3
Istoric familial:	
DZ	2
HT cronică maternă	1
Istoric de infertilitate (para 0 > 35 ani)	2
Probleme de consanguinitate	1
Interval între sarcini peste 4 ani	1
2. Factori obstetricali	
Multiparitate > 6	2
Avorturi > 1 la < 20 săptămâni de gestație	3
Prematuritate < 37 săptămâni	3
SGA < 37 săptămâni	3
SGA 37-41 săptămâni	2
SGA > 42 săptămâni	2
LGA < 37 săptămâni	3
LGA 37-41 săptămâni	2
LGA > 42 săptămâni	2
Nou-născut mort < 4 săptămâni	3
Istoric de anomalii congenitale	3
Asfixie neonatală	2
Istoric de preeclampsie	2
Eclampsie	3
Membrane rupte prematur	2
Sarcini ectopice	2
Placenta praevia	2
Distocie uterină	3
Cezariană	2
Izoimunizare Rh	3
Izoimunizare ABO	2

Creşterea ponderală:

Nou-născuții cu greutate mică la naştere apar de 2,3 ori mai frecvent la gravidele cu creştere ponderală mai mică de 9 kg, comparativ cu cele care au câştigat mai mult de 9 kg pe parcursul sarcinii, iar incidența morții fetale este de 1,5 ori mai crescută la aceeaşi categorie.

Atât greutatea dinaintea sarcinii, cât şi greutatea acumulată în timpul sarcinii au efecte importante asupra greutăţii nou-născutului. Femeile subponderale sau cele cu creştere ponderală scăzută sunt cu risc de a naşte copiii cu GN < 2500g, iar aceşti factori au influenţă aditivă. Efectul opus a fost observat la gravidele cu greutate mare înaintea sarcinii, sau cele cu câştig ponderal important pe parcursul acesteia. Greutate normală la naştere au nou-născuţii din mame anterior subponderale cu creştere ponderală mare pe parcursul sarcinii şi din mamele cu greutate anterior mare şi câştig ponderal minim. O femeie subponderală trebuie să crească în greutate cel puţin 14 kg pe parcursul sarcinii, o femeie cu greutate medie sau supraponderală – 11 kg, iar una obeză – 7 kg. Greutatea minimă câştigată pe parcursul sarcinii se recomandă a se situa între 10 şi 12 kg, distribuite astfel: 1-2 kg în primul trimestru şi câte 500g / săptămână până la naştere. Pe parcursul ultimelor două trimestre, se defineşte creşterea ponderală insuficientă sub 1 kg/ lună şi excesivă peste 3 kg/ lună.

Valoare energetică:

Energia totală consumată de sarcină este de aproximativ 20 000 calorii. Aportul mediu de energie creşte cu 50-100 cal/zi în primele 34 săptămâni şi cu 150 cal/zi în ultimele 6 săptămâni.

Aport proteic: Cerinţele de proteine în sarcină cresc cu 30 g/zi peste necesităţile din afara sarcinii, ajungând la un aport de 75-100g/zi (aproximativ 12% din aportul caloric total).

Sodiu: În timpul sarcinii au loc schimbări dramatice în metabolismul sodiului, incluzând efecte hormonale natriuretice, creşterea ratei de filtrare glomerulară şi intensificarea activităţii reninei. În trecut, sarea era complet interzisă femeilor însărcinate. Actualmente, tendinţa generală este de a permite gravidelor fără alte probleme de sănătate consumul de sare „după gust".

Fier: Hemodiluţia din timpul sarcinii scade concentraţia hemoglobinei. Creşterea aportului de fier alimentar sau medicamentos poate limita această scădere. Se estimează că este nevoie de 500mg de fier pentru creşterea volumului hematiilor materne şi 300mg pentru eritropoieza fetală. Fără suplimentarea aportului de fier, femeile îşi epuizează depozitele de fier până la sfârşitul sarcinii, aşa cum se poate demonstra prin măsurarea nivelului feritinei serice.

Calciu: O raţie zilnică de 1200mg calciu este recomandată atât pentru a răspunde necesităţilor fătului, cât şi pentru a proteja scheletul mamei, care riscă demineralizarea în timpul sarcinii şi lactaţiei. Se recomandă laptele de vacă, brânza, iaurtul, conservele de peşte (somon, sardine), lapte de soia, seminţe măcinate de susan şi vegetale verzi, care conţin cantităţi semnificative de calciu.

Alţi nutrienţi: doza recomandată de acid folic este crescută în timpul sarcinii şi este nevoie de o suplimentare cu 200-400 mg/zi pentru a ajunge la 800 mg. Sursele din dietă includ ouăle, vegetalele cu frunze verzi, portocalele, legumele şi germenii de grâu.

Procesarea grâului duce la scăderea zincului, magneziului, piridoxinei (vitamina B6) şi a vitaminei E, conţinute de acesta. Aceşti nutrienţi sunt esenţiali în timpul sarcinii. Se recomandă consumul de cereale integrale nerafinate, care sunt şi o sursă importantă de fibre alimentare. Alte surse de zinc şi piridoxină includ proteinele

animale şi legumele. Magneziul se găseşte în legume, dar nu în produsele de origine animală. Nucile şi uleiurile vegetale reprezintă o sursă excelentă de vitamina E.

În concluzie, se recomandă o dietă compusă din carne slabă, produse lactate degresate sau cu conținut scăzut de grăsime şi limitarea cantităților de grăsimi adăugate la prepararea mâncărurilor. Băuturile carbogazoase, pastele, dulciurile, mâncărurile prăjite, gustările sărate au valoare nutrițională scăzută şi trebuie evitate sau consumate cât mai rar.